

**INISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE III
FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE CONSTANTINE
SERVICE D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE**

TD de 04^{ém} année de médecine

Conduite à tenir devant une dysphagie

Présenté par : DR.M.FERMAS

Année universitaire : 2025/2026

Plan :

- I. Introduction :
 - A. Définition :
 - B. Intérêt de la question :
- II. Reconnaître la dysphagie :
 - A. Diagnostic positif :
 - B. Diagnostic différentiel :
- III. Diagnostic étiologique :
- IV. Conclusion :

I. INTRODUCTION :

A. Définition : c'est une sensation de gêne au cours de la déglutition avec un blocage du bol alimentaire dans sa progression de la bouche à l'estomac.

Elle indique soit une affection organique soit un dysfonctionnement neuromusculaire.

B. Intérêt de la question :

- « Maître symptôme de la pathologie oesophagienne.
- « Impose systématiquement une exploration de l'œsophage (le cancer de l'œsophage).
- « Explorer toute dysphagie intermittent ou fugace par une endoscopie au minimum.

II. Reconnaître la dysphagie :

A. Diagnostic positif :

1. Cas faciles : Blocage ou gêne à la progression des aliments (liquides, solide).
2. Cas difficiles :
 - Dysphagie discrète : simple sensation d'accrochage fugace ou intermittent des aliments.
 - Dysphagie noyée dans d'autres symptômes : épigastralgie, signe respiratoires ou cardio vasculaire.

B. Diagnostic différentiel :

1. Ce qui n'est pas un trouble de la déglutition :
 - **Globus hystericus** : sensation de boule permanente au niveau cervical, retrosternal ou épigastrique, permanente indépendante de la déglutition, touche surtout la femme jeune.
 - **Myricisme** :
 - **Anorexie** :
 - **Odynophagie** : douleurs retrosternale déclenchées à la déglutition.
 - **Stomatite, troubles de la mastication** :

2. Ce qui est un trouble de la déglutition mais ce n'est pas une dysphagie : toutes les causes liées aux troubles du 1^{er} temps de la déglutition.

III. Diagnostic étiologique :

A. Enquête étiologique :

1. Etape clinique :

a. Interrogatoire :

« Terrain du patient et antécédents :

- Age, sexe, habitudes Alcool-tabagiques.
- Antécédents de pyrosis (continu, intermittent).
- Antécédents de maladie générale : diabète, sclérodermie, Neurologique, Amylose.
- Notion d'alimentation sur le tube digestif.
- Notion de prise médicamenteuse (antibiotiques, dicetel, kcl...).
- Notion de prise de produits caustique.

« Caractères de la dysphagie :

- Date de début : * Ancienne : oriente vers une cause fonctionnelle.
* Récente : oriente vers une cause organique.
- Mode de début : Brutal Progressif :
- Circonstances d'apparition et degré et sélectivité de la dysphagie :
 - « Minime : intéresse les aliments solides.
 - « Importante : les aliments de petit volume et les liquides.
 - « Aphagie : impossibilité d'avaler.
- Siège : haut (oropharyngée, immédiate), moyen (thoracique, tiers moyen de l'œsophage, retrosternal), inférieur (abdominal haute, tiers inférieur de l'œsophage, retroxyphoidien).
- Mode d'évolution :
 - « Permanente continue progressive vers une Aphagie : lésion organique
 - « Intermittente : capricieuse : Trouble fonctionnel surtout et parfois cancer de l'œsophage.
- Signes accompagnateurs :
 - « Digestifs : * Douleur : odynophagie, coliques œsophagiennes,
 - * Signes de RGO :
 - * Hypersialorrhée, hoquet.
 - « Extra digestifs : respiratoires, Oropharyngées.

« Singes généraux : amaigrissement, fièvre.

b. Examen physique :

« Examen de l'état général :

- Pleur cutanée :
- Ongles cassants, chute de cheveux :
- CREST syndrome (sclérodermie) : - calcinose S/cutanée, syndrome de Raynaud, sclérodactylie, télangiectasie, troubles de la motricité œsophagienne.

« Examen digestif :

- **Cavité Bucco-dentaire :**
- **Examen abdominal pauvre cependant on doit rechercher une hépatomégalie (métastases +++).**

« Cou et région cervicale :

- palpation de la glande thyroïde.
- examen du rachis cervical.
- recherche des Adénopathies (troisier).

« Appareil respiratoire :

« Examen cardio-vasculaire :

« Examen neurologique : affections neurologiques associées.

« Examen ORL :

- Au terme de ce bilan anamnestique et clinique il n'est pas rare que la cause de la dysphagie soit soupçonnées voir reconnue.
- Cependant le plus souvent la dysphagie apparaît comme primitive mais vu le degré de la difficulté diagnostique certains examens complémentaires sont indispensables.

2. Etape paraclinique :

& Dysphagie cervicale :

- a. Examen ORL minutieux :
- b. Nasofibroscopie :
- c. Œsophagoscope : en deuxième intention.
- d. Autres : en fonction du contexte :
 - Radiographie du rachis cervical.
 - Echographie du rachis cervical.
 - TDM cervicale, cérébrale.
 - Manométrie, Phmétrie, EMG pharyngé.

& Dysphagie œsophagienne :

Examens de 1^{ère} intention : Fibroscopie digestif haute (FOGD) et le TOGD.

- a. FOGD : c'est l'examen de 1^{er} intention à faire chez un malade dysphagique.

Elle permet de :

- . Visualiser les lésions.
- . Permet des biopsies, des prélèvements cytologiques et éventuellement des colorations de la muqueuse (colorants vitaux)
- . Rôle thérapeutique :

- b. TOGD :

- Complète la FOGD.
- Permet de reconnaître les troubles moteurs et les compressions extrinsèques.
- Fait partie du bilan pré thérapeutique des obstacles organiques surtout lorsqu'ils sont infranchissables au fibroscope.

En seconde intention :

- c. La monométrie : faite lorsque la FOGD est normale ou lorsque on soupçonne une pathologie motrice.
- d. PH métrie œsophagienne : le meilleur examen pour affirmer un RGO.
- e. Echo-endoscopie œsophagienne : permet de :
- Etudier des différentes couches œsophagiennes et de la sphère périe œsophagienne.
 - Différencier impressions extrinsèques et tumeurs bénignes sous muqueuses
 - Différencier une achalasie néoplasique et primitive.
- f. Radio pulmonaire : Face/Profil : si suspicion de mega œsophage : disparition de la poche à air gastrique.
- g. Scanner thoracique :
- h. Transit œsophagien isotopique : scintigraphie :

B. Etiologies

1. Dysphagie cervicale :

- a. Causes organiques :

& Intrinsèques :

« **INFECTIEUSES :**

- Amygdalite :
- Pharyngite chronique :
- Diphtérie :

« **TUMORALES :**

- Tumeur de la base de la langue :
- Tumeur amygdalienne :
- Tumeur du pharynx :
- Tumeur du larynx :
- Tuberculose hypertrophique du larynx :

« **DIVERTICULES ET MEMBRANES :**

* **Diverticule pharyngo-oesophagien (Zenker) :** se forme sur le versant postérieur au-dessous de la bouche de Killian, affection de l'homme : 60 ans.

* **Syndrome de Plummer-Vinson :** rare, fréquent chez la femme, due à une carence profonde en fer, c'est un diaphragme muqueux très fin translucide développé à partir du bord antérieur de l'œsophage.

* **Anneau cervical :** barre cricopharyngée.

* **IATROGENE :** chirurgie cervicale, irradiation.

& Extrinsèques :

- Kyste bronchogénique :
- Adénopathies :
- Ostéomyélite cervicale :
- Ostéophytes :
- Goitre compressif :

b. Causes fonctionnelles :

& Primitives : achalasie du sphincter supérieur de l'œsophage :

& Secondaires :

- **MALADIES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL :** AVC, traumatismes cérébraux, tumeurs cérébrales, syndrome extrapyramidal (parkinson), maladie d'Alzheimer, SLA, médicaments (phénothiazine, benzodiazépine).

- **MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE :** syndrome du Guillain-Barré, poliomyélite, diphtérie, médicaments (toxine botulique...).

- **MALADIES MUSCULAIRES :** myasthénie, dermatomyosite, thyrotoxicose, métabolique, connectivite, polymyosite, sarcoïdose, botulisme, dystrophie musculaire, médicaments (amiodarone, alcool, hypocholestérolémiants).

2. Dysphagie œsophagienne :

a. Causes organiques :

& Intrinsèques :

« **TUMORALE :**

* **Tumeurs malignes :**

- **Cancer Epidermoïde de l'œsophage :**

- plus fréquent chez l'homme que chez la femme surtout sujet âgé.

- Alcool-tabagique
- Dysphagie récente, progressive, d'abord aux solides, puis aux liquides, puis aphasie.
- Douleurs rétro-sternales, régurgitations sanglantes, sialorrhée, hoquet
- Régurgitation d'aliments digérés.
- Altération rapide de l'état général.
- Parfois hépatomégalie tumorale, ganglion de Troisier.
- Examen ORL : tumeur synchrone.
- **FOGD** : lésions bourgeonnantes avec ulcère à contour indurés saignant au contact ou une sténose irrégulière infranchissable.
- Traitement : chirurgical, radiothérapie.
- **Adénocarcinome** : plus rare, siège sur endobrachyoesophage dans 10 % des cas soit extension d'un adénocarcinome du cardia.
- * **Tumeurs bénignes** : rares, elles ne sont symptomatiques que lorsqu'elles sont volumineuses.

« INFLAMMATOIRES :

* Œsophagites :

- **Sténose peptique** : voir cours : RGO.

- **Œsophagite caustique** :

« OESOPHAGITE INFECTIEUSE :

* Œsophagite mycosique :

* Œsophagite virale : HSV1, CMV, HIV

* Tuberculose :

* Syphilis :

« OESOPHAGITE POST RADIQUE :

« OESOPHAGITE MEDICAMENTEUSE : Doxycycline, Bromure de pinaverium, chlorure de K⁺.

« ANNEAUX :

* **Anneau de SCHATZKI** : c'est un diaphragme muqueux situé au-dessus d'une hernie hiatale.

* **Syndrome de PLUMMER-VINSON ou de KELLY PATTERSON** :

« DIVERTICULES :

* **Diverticule pharyngo oesophagien de ZENKER** :

* **Diverticule épiphrénique** :

* **Diverticule médiathoracique ou para bronchique** :

& extrinsèques :

« CAUSES TUMORALES :

* **Tumeur médiastinale** :

* **Maladie de Hodgkin** :

* **Goitre plongeant** :

* **Adénopathies médiastinales** : médiastinales : Tuberculose, Sarcoidose

« CAUSES CARDIAQUES OU VASCULAIRES :

* **Dysphagia Lusoria** :

* **Anévrisme de l'aorte (syphilis)** :

- * **Péricardite de grande abondance :**
- * **Hypertrophie auriculaire gauche (RM) :**
- « **COMPRESSION D'ORIGINE OESOPHAGIENNE OU GASTRIQUE :**
- * **Diverticule de ZINKER ou diverticule pharyngo-oesophagien :**
- * **Hernie hiatale par roulement :**
- * **Pathologie abdominale :** kyste hydatique du foie gauche, cancer de la grosse tubérosité, cancer du pancréas du pancréas...

b. Cause fonctionnelles :

& Causes fonctionnelles primitives :

- « **ACHALASIE OU MEGA ŒSOPHAGE IDIOPATHIQUE :** c'est un désordre généralisé de la motricité œsophagienne du à une perte de l'intégration des stimulations.
- Secondaire à une raréfaction des plexus myentériques de Meissner et Auerbach au niveau du bas-œsophage.
- Clinique : dysphagie paradoxale
- Téléthorax : élargissement du médiastin para-cardial droit avec niveau liquidien médiastinal et signes de pneumopathie. Absence de poche à air gastrique.
- Transit baryté œsophagien : dilatation du corps de l'œsophage avec rétrécissement en queue de radis ou en bec d'oiseau de la portion terminale de l'œsophage. Aspect en chaussette au stade tardif.
- FOGD : œsophage dilaté et atone. Signe du ressaut au franchissement du Cardia.
- Manométrie œsophagienne : Examen clé pour le diagnostic :
 - Hypopéristaltisme du corps œsophagien.
 - Hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage au repos.
 - Absence de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage lors de la déglutition.
- Traitement :
 - Médical :dérivés nitré) : effet temporaire
 - Dilatation pneumatique.
 - Cardiomyotomie de Heller.
- « **SYNDROME DES SPASMES ETAGES :**
- « **PERISTALTISME DOULOUREUX :**
- « **ANOMALIES MOTRICES NON SPECIFIQUES :**

& Causes fonctionnelles secondaires :

- « **LESION NERVEUSE CENTRALE :**
- * **Sclérose latérale amyotrophique (SLA) :**
- * **Sclérose en plaque (SEP) :**
- * **Chorée de Huntington :**
- * **Syndrome pseudo-bulbaire :**

« **ATTEINTE MUSCULAIRE PRIMITIVE :**

* **Myasthénie :**

* **Myotonie dystrophique :**

* **Dermato myosite :**

« **Maladies générales :**

* **Sclérodermie :**

* **Maladie de CHAGAS :**

IV. Conclusion :

La dysphagie est un symptôme et non une maladie, le plus important est de chercher sa cause, en priorité un cancer de l'œsophage, une affection de voisinage ou une cause générale d'où une enquête minutieuse et un bilan complet et précis.